本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



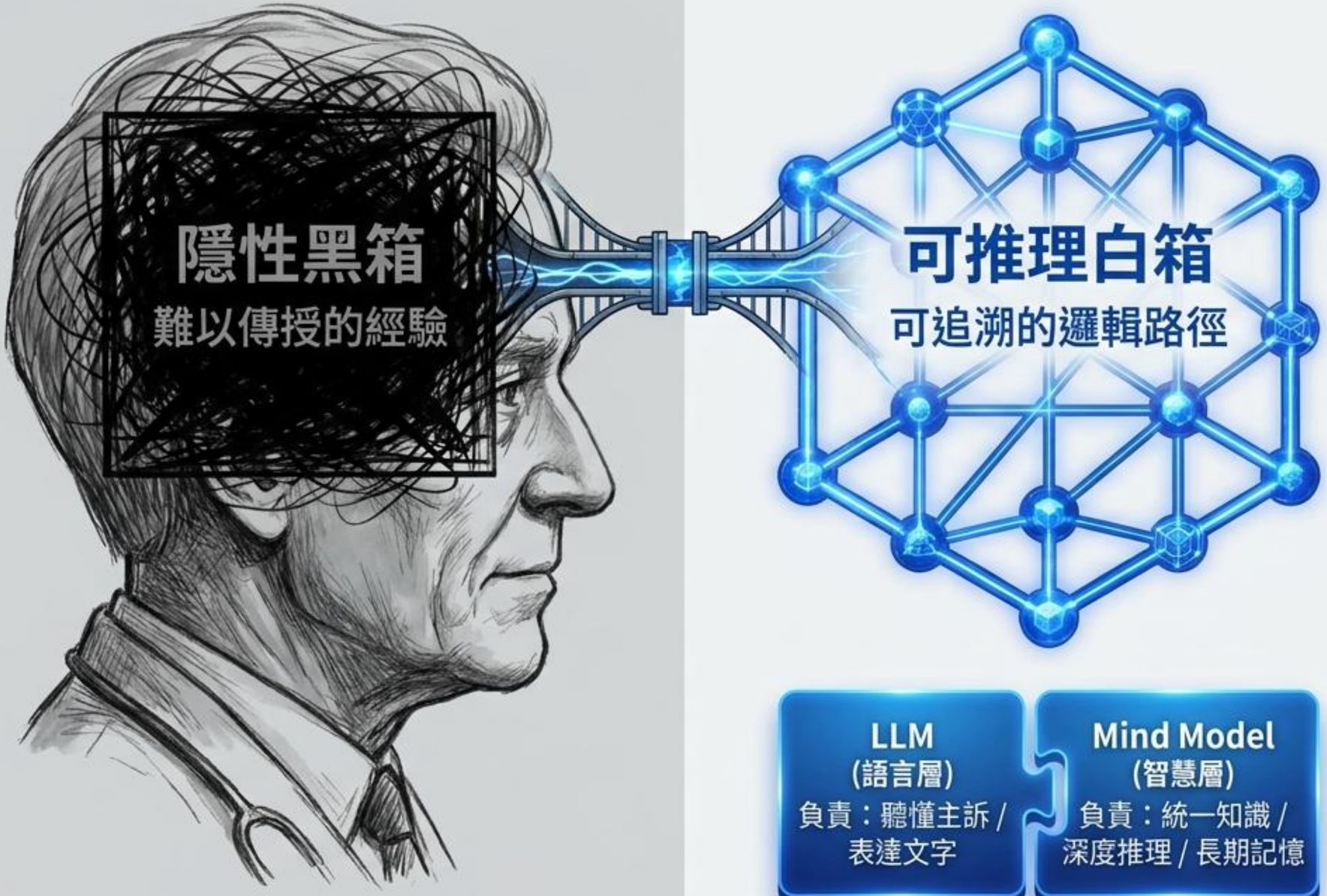
AI 中醫問診與開方：產出準確使用方法完全方案

從望聞問切到複診調方的可推理副本 (Mind AI × 本形學)



重要聲明：本簡報出現之方藥內容僅供方法示範，不構成醫療建議。

MIND AI



可推理白箱

可追溯的邏輯路徑

LLM
(語言層)
負責：聽懂主訴 / 表達文字

Mind Model
(智慧層)
負責：統一知識 / 深度推理 / 長期記憶

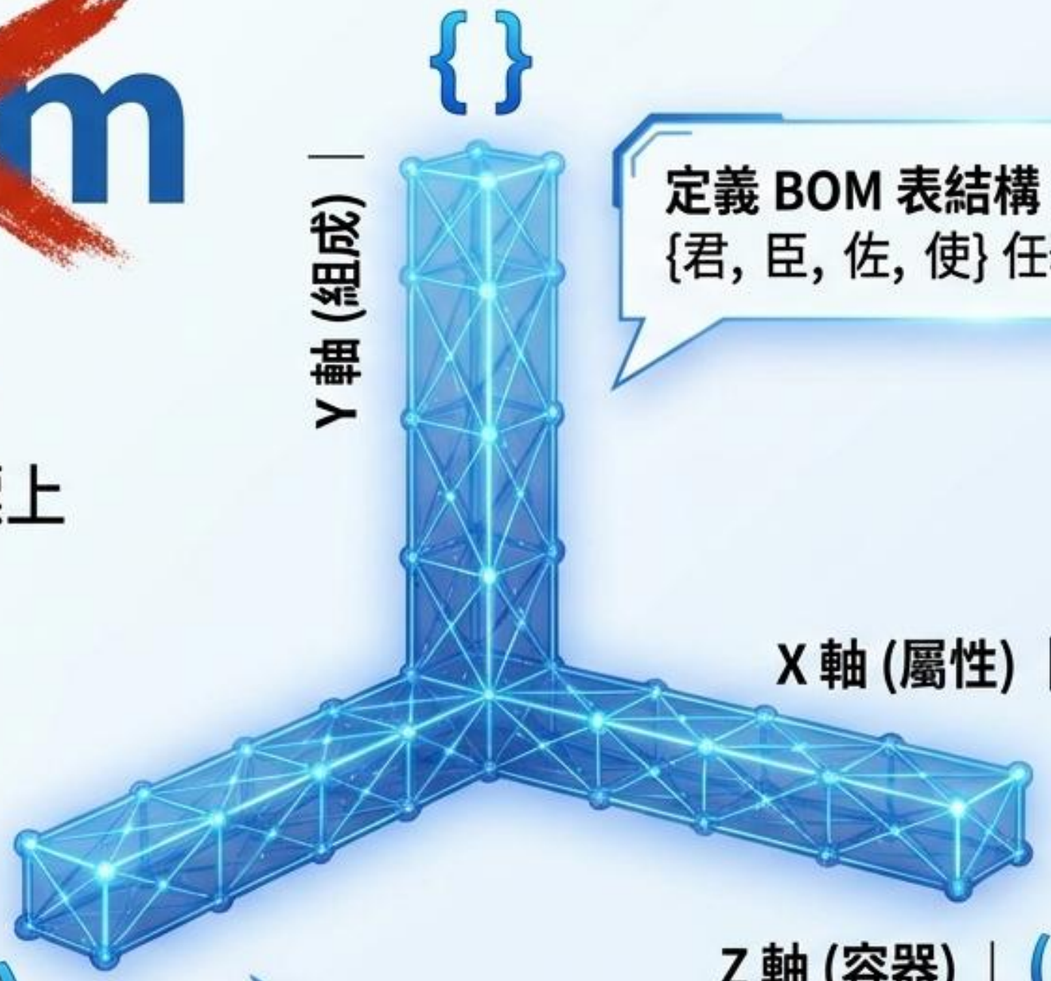
語言轉換矩陣：醫理與形數的對接	
望聞問切 →	**四診形** (ExamType)：所見欄位化
辨證 →	**證型形** (SyndromeType)：特徵集合過 ∩(T)
病因病機 →	**病機形** (MechanismType)：因→機→證因果鏈
治則治法 →	**治法形** (TreatmentType)：一機一法對應
處方 →	**方劑形** (FormulaType)：君臣佐使 BOM 表
複診 →	**複診形** (FollowType)：療效對照與演化

MIND AI

Type Form

核心約定：形 = Type

空間本形：將隱性醫理釘在立體座標上



定義 BOM 表結構（如：方劑的 {君, 臣, 佐, 使} 任務配置）

X 軸 (屬性) | **[ ] 抽象集合**

[ ]

Z 軸 (容器) | **( ) 容器集合**

定義屬性與資格
(如：特徵是否歸入 [不寐] 證型)

定義 BOM 表結構
(如：方劑的 {君,臣,佐,使} 任務配置)

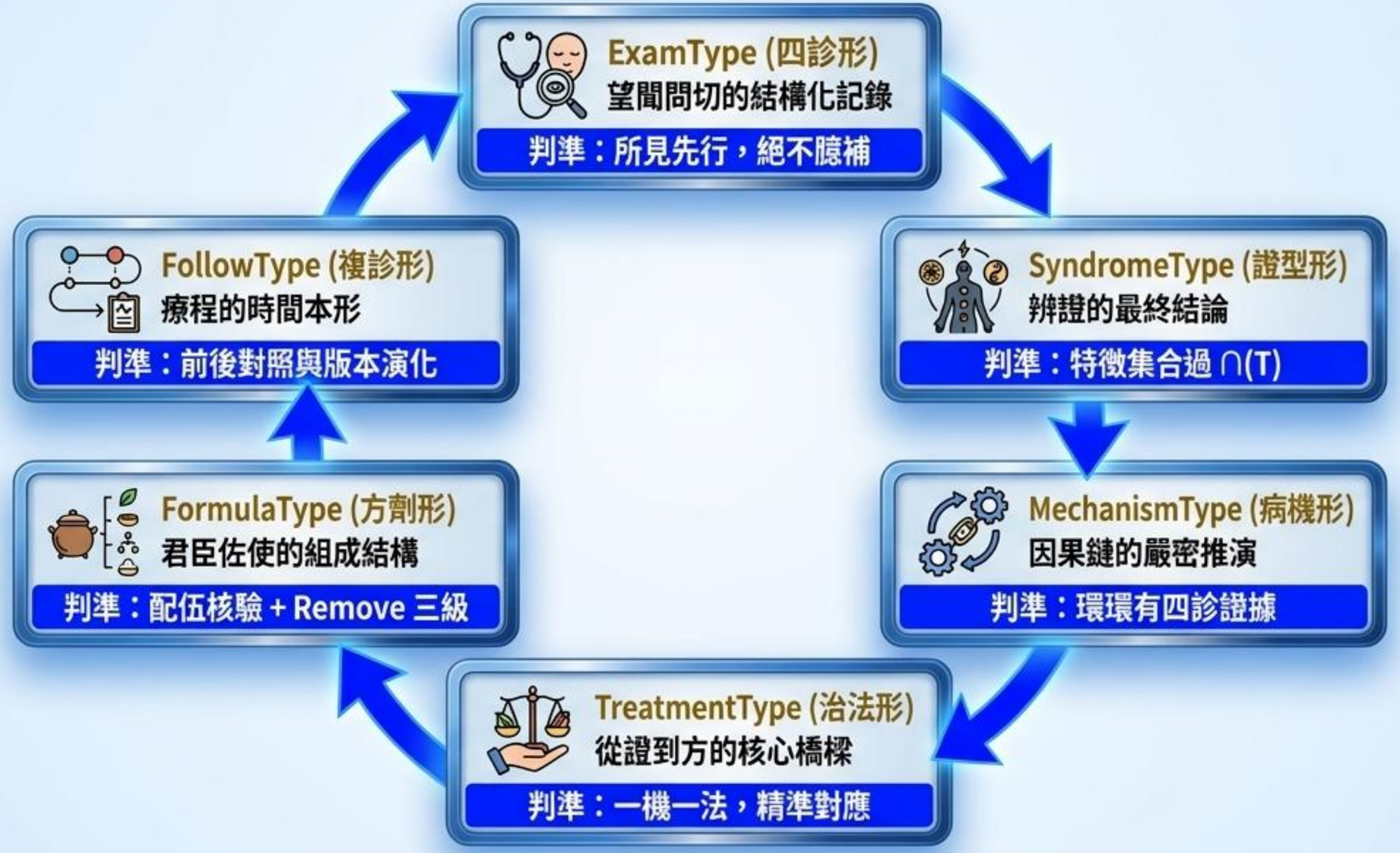
( )

( ) 容器集合

定義身份錨定 id(C)
(如：(林小姐) 的人體容器與本次病程)

MIND AI

問診開方的六種產出形 (The 6 Output Types Ecosystem)



MIND AI

深探一：所見先行與辨證漏斗

ExamType ⟶ SyndromeType



深探二：嚴密咬合的病機鏈與治法橋樑

MechanismType & TreatmentType

核心法則：
一機一法，逐環對應。
鏈條斷裂，則治法無基。

橋樑 (TreatmentType 治法形)
補益心脾、養血安神

齒輪 1：因
思慮過度

齒輪 2：機
暗耗心血 / 脾失健運

齒輪 3：證
心脾兩虛

四診證據支撐：
問診：思慮多、文職

四診證據支撐：
心悸健忘、食少納呆

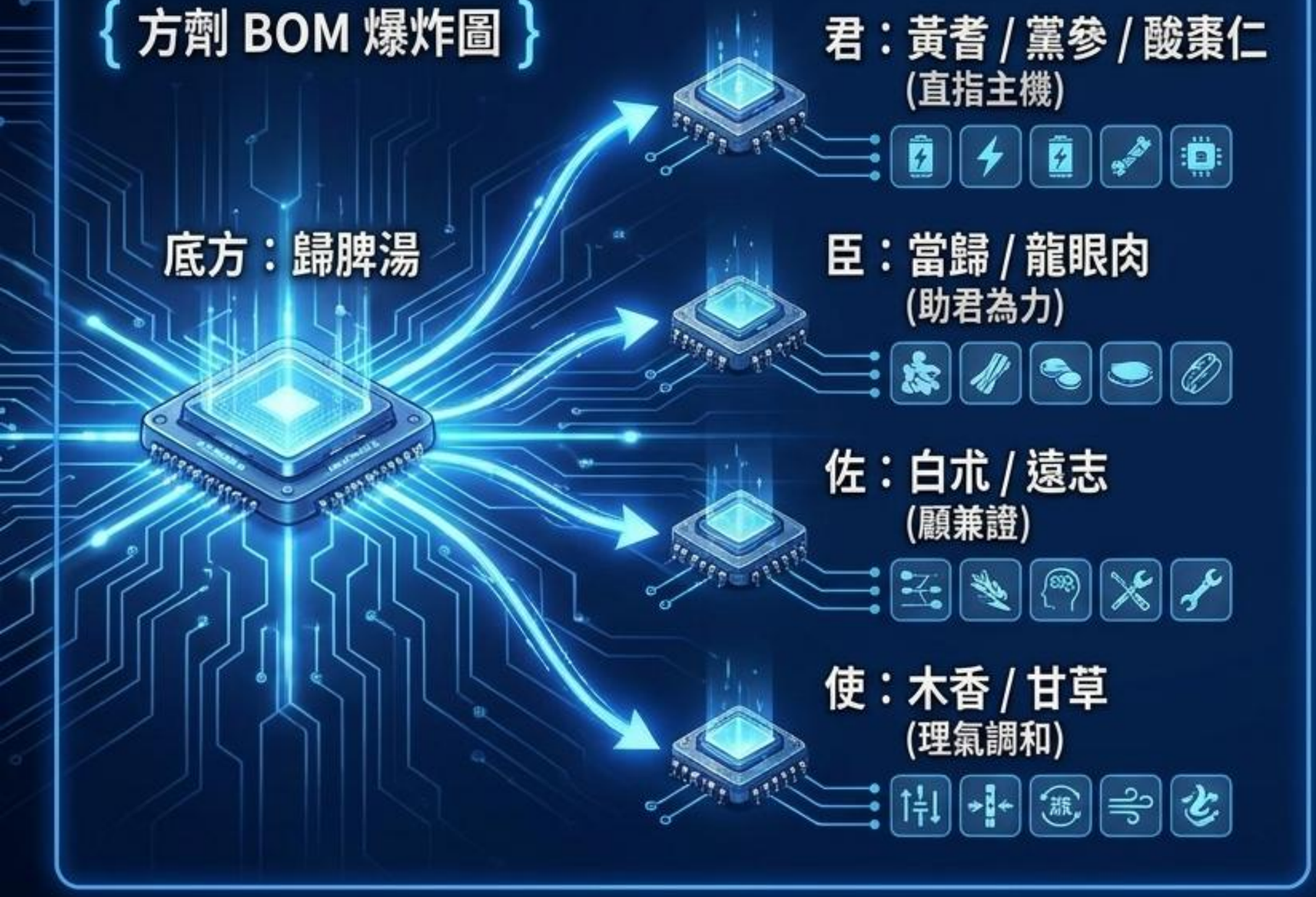
四診證據支撐：
面色少華、舌淡、脈細弱

MIND AI

深探三：方劑 BOM 拆解與反事實壓力測試

FormulaType & Remove 3-Levels

{ 方劑 BOM 爆炸圖 }



反事實壓力測試儀 (Remove 三級)



一級 (拆單味)
拿掉它，任務落空嗎？

二級 (拆藥對)
拿掉它們，成對失守嗎？





三級 (拆方根)
拿掉骨架，治法還站得住嗎？

＊皆通過才准加減

MIND AI

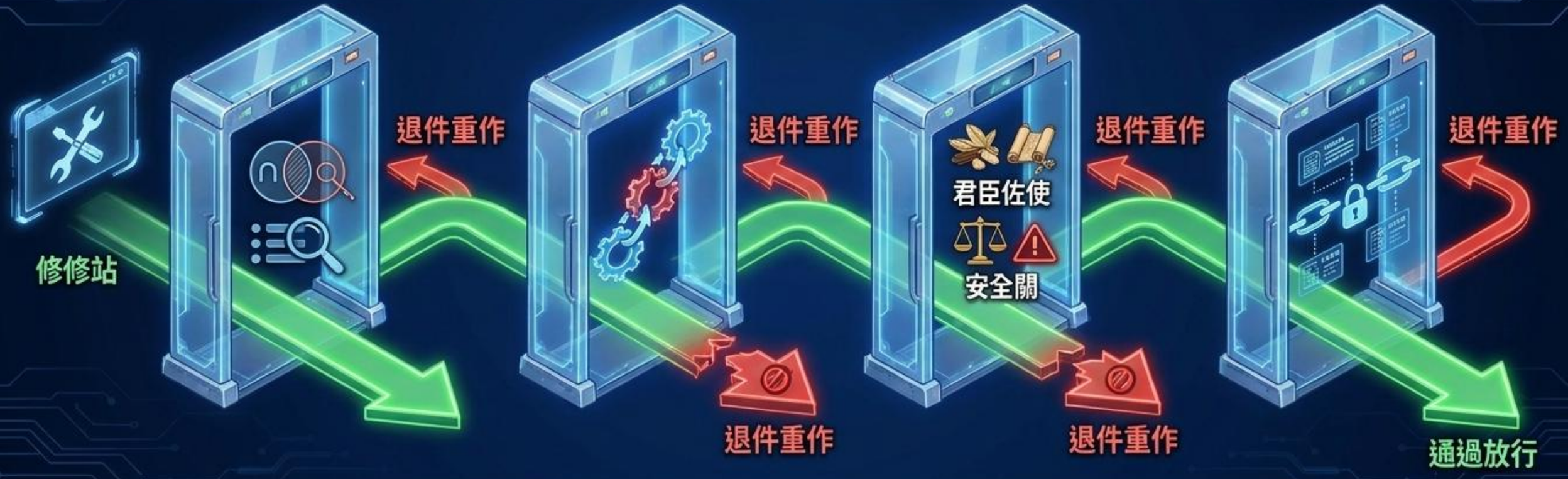
準確不能靠感覺：四層準確性安檢門

第一層：∩(T) 辨證判準
過濾特徵集合，
必須包含排除鑑別

第二層：演繹骨架
病機因果推演鏈，
檢查是否斷環

第三層：醫理核方
結構關：君臣佐使任務 /
安全關：十八反十九畏、劑量

第四層：形證據鏈
全程可回溯性
確保每步皆有依據



絕不帶著疑點出方！任一安檢未過，即刻阻斷流程並退回修補。

MIND AI

形證據鏈的全面回溯 (The Traceability Chain)

追問憑什麼時，每一步都答得出上一步。



藥味
這味藥憑什麼開？
指回 → 治法形
(對應任務)

治法形
這治法憑什麼立？
指回 → 病機形
(對應主機)

病機形
這病機憑什麼推？
指回 → 證型形
(對應證候)

證型形
這證型憑什麼下？
指回 → 四診形
(對話原始所見)

MIND AI

實戰前置：六步驟與三層邏輯判斷

系統啟動需求認明：定對象 → 定範圍 → 定目標 → 定約束



最外圈：( ) 容器判斷

中間圈：{ } 組成判斷

最內圈：[ ] 抽象判斷

操作警告：
跳層是卡關主因。切勿跳過容器身分直接推演抽象證型。

MIND AI

S1-S7 提示詞流水線地鐵圖 (The S1-S7 Prompt Pipeline)



S1-S7 提示詞流水線地鐵圖 (The S1-S7 Prompt Pipeline)

全案演練 (上)：林小姐不寐醫案 (S1-S3 落地推演)

Card 1: S1 四診形 (ExamType)

主訴輸入：失眠兩個月、心悸、面色少華

必填檢驗：舌淡、脈細弱

主診桌檢測

邊膜檢測

舌淡脈細弱

Card 2: S2 證型形 (SyndromeType)

辨證輸出：不寐·心脾兩虛證

雷達圖對照 ∩(T) 判準



備註：排除肝鬱化火

Card 3: S3 病機形 (MechanismType)

因：思慮過度

機：脾失健運

證：心神失養

四診證據精準對齊

MIND AI

全案演練 (下)：處方箋與複診調方 (S5-S7 閉環)

S5：方劑形 (FormulaType) 處方箋

底方：歸脾湯加減

品名：	容量：	劑頻：
獲健人數：	禁腋：	貨俏：

【君】黃耆 15g、黨參 12g、酸棗仁 15g
【臣】當歸 10g、龍眼肉 12g、茯神 12g
【佐】白朮 12g、遠志 6g
【使】木香 6g、甘草 3g、大棗、生薑

動態加減：
加柏子仁 10g (任務：強化安神，對應多夢)

S7：複診形 (FollowType) 時間軸



＊方藥劑量僅供方法

實操防身指南：誤用地雷與出方自查清單

五種失去「形」的誤用地雷



1. 跳過四診直接開方
(證據鏈斷裂)



2. 憑單一症狀定證型
(無視 ∩(T) 判準)



3. 方劑隨手湊藥
(缺乏 BOM 結構)



4. 加減無醫理依據
(任務落空)



5. 複診只問好點沒
(無結構化沉澱)

起飛前：出方核心自查清單

- [x] 舌脈有欄位標示嗎？
- [x] 排除鑑別寫得出來嗎？
- [x] 十八反十九畏查過了嗎？
- [x] 每味藥指得回治法嗎？

MIND AI

持續演化：空間與時間的交叉驗收 (Maturity Model)

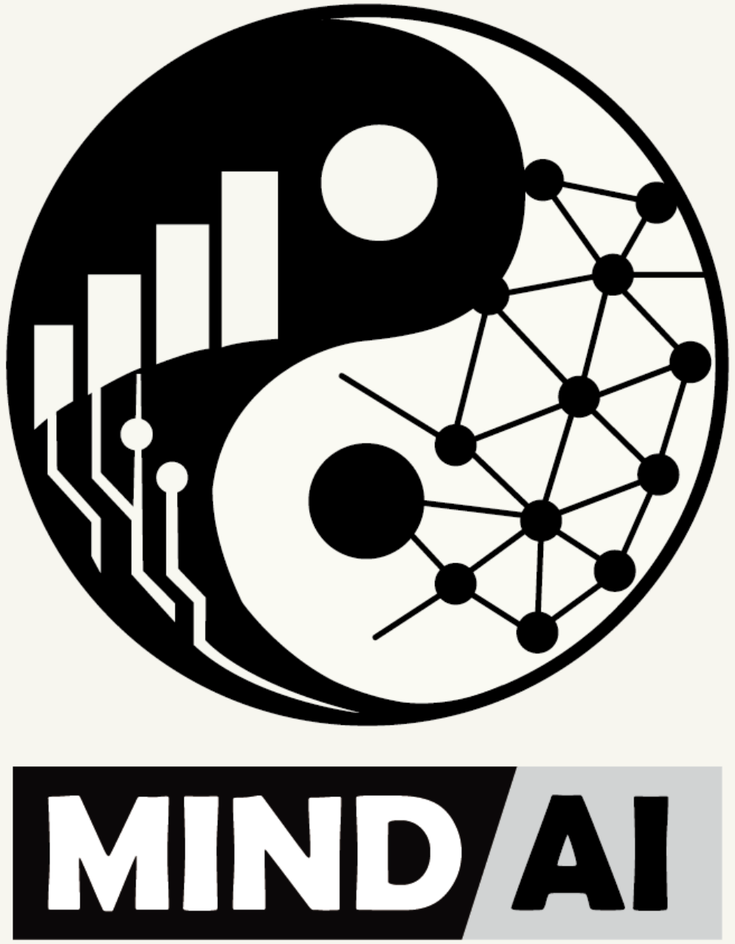


準確來自空間結構的把關與時間維度的交叉驗收。L4 不是終點，而是越開越準的開始。

重要聲明：本簡報出現之方藥內容僅供方法示範，不構成醫療建議。

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com